PROFESIONAL

EJE 3 · NUEVOS DESAFÍOS DE LA SALUD Y EL CUIDADO

Cuidar a quienes cuidan: Terapia Ocupacional para prevenir el desgaste ocupacional en enfermería

González, A. J.[1]

[1] Licenciada en Terapia Ocupacional

1 INTRODUCCIÓN

El personal de enfermería sostiene el cuidado hospitalario las 24 horas, con turnos rotativos, alta demanda emocional y tareas de esfuerzo físico, y dispone de poco tiempo para su propio autocuidado. Esta exposición sostenida favorece el desgaste ocupacional, un fenómeno vinculado al estrés crónico en el trabajo (Maslach y Leiter, 2016; OMS, 2019), que afecta la salud de las personas y también la calidad y la seguridad de la atención.

La Terapia Ocupacional entiende que el equilibrio entre las ocupaciones cotidianas incide en la salud (Wilcock, 1998) y que el desempeño depende de la relación entre persona, ocupación y entorno (AOTA, 2020). Desde esa mirada, quienes cuidan también pueden ser destinatarios de intervención.

Las estrategias aisladas suelen ser difíciles de sostener; por eso se propone integrar a la persona, el entorno y el equipo en una misma propuesta.

2 OBJETIVOS

Objetivo general: Proponer un abordaje interprofesional, entre Terapia Ocupacional y Enfermería, para prevenir el desgaste ocupacional en el ámbito hospitalario.

Objetivos específicos:

- Describir tres ejes de intervención aplicables en el servicio.
- Identificar el aporte de la Terapia Ocupacional al cuidado del personal de enfermería.

3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Propósito: diseñar un abordaje preventivo para servicios hospitalarios, integrable a la rutina de trabajo.

Destinatarios: personal de enfermería de servicios de internación y de atención ambulatoria.

Ejes de intervención:

- Pausas activas y de regulación: micropausas, respiración, estiramientos y espacios de descanso.
- Ergonomía y mecánica corporal: movilización y posicionamiento seguros, organización del espacio y ayudas técnicas.
- Equilibrio ocupacional: balance entre trabajo, descanso, ocio y vida personal, y recuperación entre turnos.

Procedimiento: (1) evaluar el entorno y la rutina del servicio; (2) diseñar con el equipo estrategias breves y viables; (3) educar y acompañar en los tres ejes de intervención; (4) revisar y ajustar en conjunto.

Roles: Terapia Ocupacional coordina la evaluación y la capacitación; Enfermería aporta el conocimiento del servicio y valida cada estrategia.

4 LOGROS Y APRENDIZAJES ESPERADOS



Figura 1. Ejes de intervención de la propuesta. Fuente: elaboración propia.

3
ejes de intervención: pausas, ergonomía y equilibrio

2
disciplinas que trabajan en conjunto: TO y Enfermería

Se espera que la propuesta permita:

- Reducir la sobrecarga física con posturas y movilizaciones más seguras.
- Incorporar pausas breves y espacios de descanso con ambiente sensorial calmo.
- Mejorar el equilibrio entre trabajo, descanso, ocio y vida personal.
- Favorecer hábitos saludables y la recuperación entre turnos.
- Fortalecer el trabajo interprofesional y la comunicación dentro del servicio.

Aprendizajes que orientan la propuesta: las estrategias breves y acordadas con el equipo son más sostenibles; el entorno importa tanto como la persona; el autocuidado es también una responsabilidad institucional. El impacto puede evaluarse con la percepción del equipo, el ausentismo y la satisfacción laboral.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

Cuidar a quienes cuidan es una condición necesaria para un cuidado seguro y humanizado.

La propuesta responde a los objetivos: ofrece ejes concretos y viables para prevenir el desgaste ocupacional desde una mirada interprofesional. Su alcance es preventivo y requiere adaptarse a cada servicio. Como limitación, aún no cuenta con datos de implementación; el próximo paso es probarla en un servicio y medir su impacto junto al equipo, ajustando las estrategias según lo que el propio personal reconozca como útil.

6 APORTE A ENFERMERÍA

Incorpora la ocupación, el entorno y las rutinas como focos del cuidado del propio equipo. Puede aplicarse en otros servicios y niveles de atención y sumarse a la formación continua, con estrategias de bajo costo que fortalecen la salud del personal, el trabajo en equipo y la calidad de la atención.

7 REFERENCIAS

American Occupational Therapy Association. (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process (4th ed.). American Journal of Occupational Therapy, 74(Suppl. 2), 7412410010. https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001

Maslach, C. y Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103–111. https://doi.org/10.1002/wps.20311

Organización Mundial de la Salud. (2019). Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases. https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases

Wilcock, A. A. (1998). An occupational perspective of health. SLACK.